



PORADNIK
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

WYDANIE OPARTE NA BADANIACH



ECHOLALIA W AUTYZMIE

Echolalia pod lupą nauki

*Co naprawdę wiemy o
przyczynach powtarzania — i
co z tego wynika w klasie i w
domu.*

Dla rodziców, nauczycieli i terapeutów

Siedem mechanizmów opisanych w literaturze — każdy z uczciwą oceną siły dowodów.

POMORSKIE CENTRUM
TERAPII PEDAGOGICZNEJ
WYDANIE I

O tej broszurze

Materiał powstał, żeby oddzielić to, co o echolalii *wiadomo*, od tego, co się o niej powtarza bez pokrycia.

W literaturze popularnej echolalia bywa opisywana albo jako objaw do wygaszenia, albo jako w pełni zrozumiany etap rozwoju o ustalonych fazach. Żadne z tych ujęć nie jest wierne stanowi badań. Ta broszura porządkuje temat inaczej: przy każdym mechanizmie podajemy **siłę dowodów** — od ustaleń powtórzonych w niezależnych badaniach po hipotezy, które dopiero czekają na weryfikację.

♦ DLA KOGO

Dla rodziców dzieci autystycznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i specjalnej, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów. Nie zakładamy przygotowania medycznego — terminy fachowe wyjaśniamy w słowniczku na stronie 17.

TYTUŁ Echolalia pod lupą nauki. Co naprawdę wiemy o przyczynach powtarzania

SERIA Poradniki edukacyjno-terapeutyczne PCTP

WYDANIE Pierwsze

OBJĘTOŚĆ 19 stron A4, 17 pozycji bibliograficznych

FORMAT Do druku dwustronnego oraz do dystrybucji cyfrowej (PDF)

ILUSTRACJE Autorskie grafiki wektorowe wykonane na potrzeby tego wydania

▲ ZASTRZEŻENIE

Broszura ma charakter **edukacyjny**. Nie zastępuje diagnozy ani indywidualnej konsultacji ze specjalistą. Opisane strategie są wsparciem, a nie protokołem terapeutycznym — decyzje dotyczące konkretnego dziecka zawsze podejmuje zespół pracujący z nim na co dzień, wspólnie z rodziną.

♦ ZASADA DOBORU ŹRÓDEŁ

Cytujemy wyłącznie prace opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych oraz przeglądy systematyczne. Tam, gdzie popularny model nie ma potwierdzenia empirycznego, mówimy o tym wprost — nawet jeśli jest szeroko stosowany.

+ TRZY PYTANIA, NA KTÓRE TA BROSZURA ODPOWIADA

Dlaczego moje dziecko powtarza? → Rozdziały II i III: siedem mechanizmów, każdy z oceną siły dowodów.

Czy to znaczy, że coś jest nie tak? → Rozdział IV: echolalia występuje także w rozwoju typowym i nie jest objawem diagnostycznym.

Co mogę zrobić jutro? → Rozdział V: cztery konkretne zachowania dorosłego i strona do powieszenia w klasie.

Spis treści

I Punkt wyjścia 05

Echolalia w liczbach	05
Dwie twarze echa: natychmiastowe i odroczone	06
Siedem funkcji echolalii natychmiastowej	06

II Co jest naprawdę udowodnione 07

Skala siły dowodów — jak czytać tę broszurę	08
1 · Obciążenie językowe i trudność w rozumieniu	08
2 · Echolalia pełni funkcje komunikacyjne	08
3 · Przetwarzanie całościowe języka	09
4 · Pamięć dosłowna i długotrwała	09

III Co dzieje się w mózgu 10

Grzbietowy szlak powtarzania mowy	11
5 · Powtarzanie jako osobny obwód	11
6 · Osłabione hamowanie automatycznej imitacji	12
7 · Regulacja pobudzenia i napięcia	12

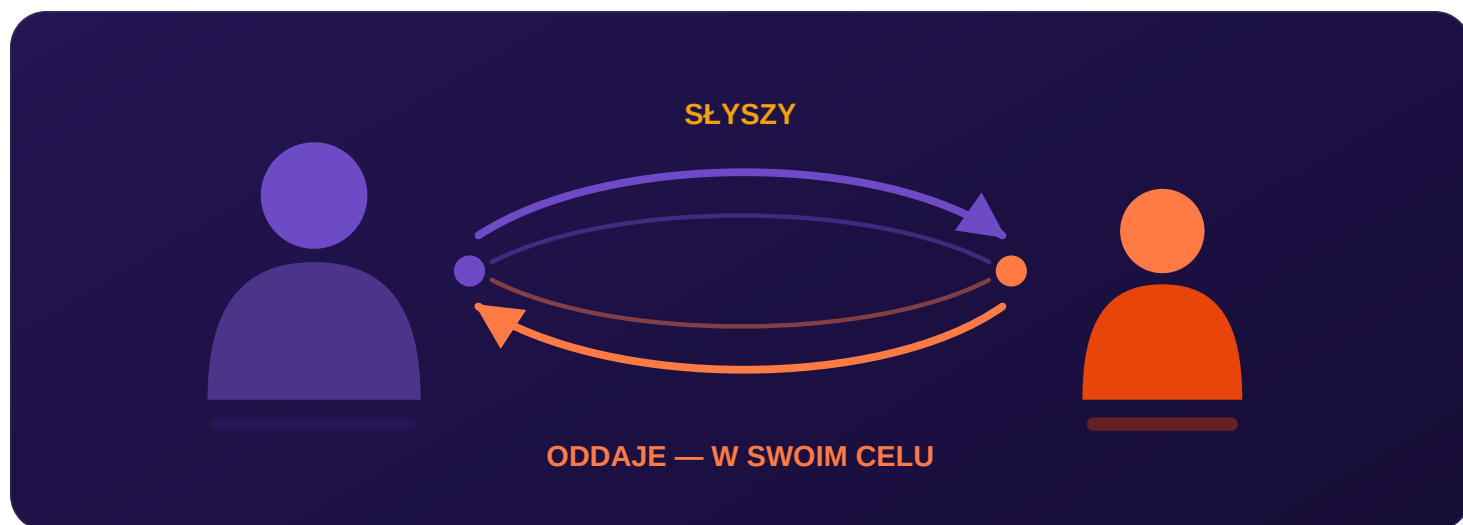
IV Szerszy obraz 13

Echolalia nie należy do autyzmu	13
Pół wieku badań — oś czasu	14
Czego nauka nie potwierdziła	15

V Praktyka i materiały 16

Cztery rzeczy, które z tego wynikają	16
Słowniczek pojęć	17
Bibliografia	18
Szybka ściągawka do powieszenia	19

Pytanie, które zmieniło wszystko



RYC. 1 ECHO NIE JEST KOPIĄ. FRAZA WRACA ZMIENIONĄ FUNKCJĄ, JAKĄ NADAJE JEJ DZIECKO.

Przez dziesięciolecia badacze pytali o echolalię tak, jak pyta się o objaw: *jak ją wygasić?* W 1981 roku Barry Prizant i Judith Duchan postawili pytanie inaczej — **po co dziecko powtarza?** — i to przeformułowanie zmieniło całą dziedzinę ^[1].

Okazało się, że echolalia nie jest pustym dźwiękiem. Bywa prośbą, zgodą, protestem, sposobem na utrzymanie rozmowy, próbą zrozumienia zdania przez wypowiedzenie go na głos albo kotwicą, która pozwala przetrwać zbyt głośne popołudnie. Kiedy patrzy się na formę, widać powtarzanie. Kiedy patrzy się na funkcję — widać komunikację.

Echolalia to nie zakłócenie na drodze do mowy. To bardzo często sama droga.

SYNTEZA USTALEŃ PRIZANTA I DUCHAN, 1981–1984

Ta broszura prowadzi przez siedem mechanizmów, którymi nauka tłumaczy powstawanie echolalii. Nie wszystkie są równie pewne — i właśnie dlatego przy każdym z nich znajdziesz ocenę siły dowodów. Uczciwość wobec tego, czego jeszcze nie wiemy, jest tu równie ważna jak to, co udało się ustalić.

Co ta broszura robi inaczej

Masz mało czasu? Przeczytaj stronę 16 i powieś ściągawkę ze strony 19 — reszta wyjaśnia, **dla czego** to działa.

Podaje siłę dowodów

Przy każdym mechanizmie widać, czy wynik został powtórzony w niezależnych badaniach, czy jest dopiero hipotezą. Nic nie udaje pewności, której nie ma.

1

Nazywa to, co niepotwierdzone

Także wtedy, gdy dotyczy to modelu szeroko stosowanego w praktyce i sprzedawanego na szkoleniach.

2

Kończy na konkretach

Każde ustalenie prowadzi do jednego zdania, które da się powiedzieć dziecku jutro rano.

3

Czego tu nie ma

Gotowego protokołu terapeutycznego i obietnicy, że jedna metoda zadziała u każdego dziecka. Badania nie dają podstaw ani do jednego, ani do drugiego.



Echolalia w liczbach

Cztery liczby, które porządkują skalę zjawiska — i pokazują, jak dawno zaczęto je badać.

75%

Szacunkowy odsetek mówiących osób autystycznych, u których echolalia pojawia się na którymś etapie rozwoju mowy. To zjawisko typowe, nie marginalne.

PRIZANT, 1983 [6]

30mies.

Do mniej więcej tego wieku echolalia jest normalnym etapem rozwoju mowy u każdego dziecka. Powtarzanie to naturalny sposób wchodzenia w język.

ROZWÓJ TYPOWY • LITERATURA PRZEGLĄDOWA

7 + 14

Tyle odrębnych **funkcji** echolalii opisano w klasycznych badaniach: siedem dla echolalii natychmiastowej i czternaście dla odroczonej.

PRIZANT I DUCHAN, 1981 [1] • PRIZANT I RYDELL, 1984 [3]

2555

Liczba uczestników największej analizy zgłoszeń echolalii. Potwierdziła jej dwoistą naturę: bywa jednocześnie komunikacją i zachowaniem powtarzalnym.

MCALLISTER I WSP., 2025 [5]

▲ PIĄTA LICZBA: 1968

Rok pierwszego kontrolowanego badania odpowiedzi echowych [17]. Echolalia jest przedmiotem systematycznych badań od ponad pół wieku — ale przełom nie polegał na znalezieniu „przyczyny”. Polegał na zmianie pytania.

♦ DEFINICJA ROBOCZA

Echolalia to powtarzanie usłyszanych wypowiedzi — cudzych lub własnych — w formie identycznej albo lekko zmienionej. Powtórzenie może nastąpić natychmiast albo po godzinach, dniach, a nawet miesiącach od usłyszenia.

+ CO Z TYM ZROBIĆ JUTRO

Przez tydzień notuj przy każdym echu trzy rzeczy: **co je poprzedziło, jak głośne było i czy dziecko patrzyło na kogoś**. Po tygodniu wzorec zwykle staje się widoczny bez żadnych narzędzi diagnostycznych.

Dwie twarze echa

Podział na echolalię natychmiastową i odroczoną nie jest formalnością. Za każdą stoi inny mechanizm pamięciowy i inna praktyczna wskazówka.



Natychmiastowa

w ciągu sekund

Powtórzenie tego, co właśnie padło. Opiera się na pamięci krótkotrwałej i przetwarzaniu „powierzchownym”.

SYGNAŁ

Zdanie było za trudne — uprość



Odroczona

godziny, dni, miesiące

Fraza z bajki, reklamy, dawnej rozmowy — często z zachowaną intonacją. Angażuje pamięć długotrwałą.

SYGNAŁ

Poszukaj źródła — tam jest sens

RYC. 2 RÓŻNY MECHANIZM PAMIĘCIOWY, RÓŻNA WSKAZÓWKA DLA DOROSŁEGO.

♦ PRAKTYCZNY SYGNAŁ Z BADAŃ

Cohn i współpracownicy ^[9] zauważyli prostą regułę, którą łatwo sprawdzić w klasie: **echa komunikacyjne są zwykle głośniejsze** od niekomunikacyjnych. Ciche, mrużane powtarzanie częściej służy samoregulacji; wyraźne, skierowane do kogoś — komunikacji.

Siedem funkcji echolalii natychmiastowej

Klasyfikacja Prizanta i Duchan ^[1] — do dziś podstawa większości narzędzi obserwacyjnych.

FUNKCJA	SKIEROWANA DO	JAK TO WYGLĄDA
Podtrzymanie wymiany	rozmówcy	Dziecko wypełnia swoją kolej w rozmowie, choć nie ma jeszcze własnych słów.
Potwierdzenie	rozmówcy	Powtórzenie zamiast „tak”: „Chcesz sok?” → „Chcesz sok.”
Prośba	rozmówcy	Powtórzenie frazy, po której zwykle coś następowało.
Deklaracja	rozmówcy	Nazwanie tego, co dziecko właśnie widzi lub robi.
Ćwiczenie	siebie	Powtórzenie „na próbę”, zanim padnie właściwa odpowiedź.
Samoregulacja	siebie	Fraza steruje własnym działaniem albo obniża napięcie.
Niezogniskowana	—	Bez czytelnej intencji, często przy wysokim pobudzeniu lub zmęczeniu.

II

ROZDZIAŁ DRUGI

Co jest naprawdę udowodnione

Nie istnieje jedna „przyczyna eholalii”.
Istnieje kilka mechanizmów o bardzo
różnej sile dowodów — i to rozróżnienie
jest praktycznie najważniejsze w całej
broszurze.

● SKALA SIŁY DOWODÓW ● CZTERY MECHANIZMY ● OSTRZEŻENIE O MODELU NLA

Jak czytać oceny w tej broszurze

Każdy mechanizm dostaje jedną z trzech ocen. Kolor karty powtarza tę ocenę, więc widać ją, zanim zacznie się czytać.



UDOKUMENTOWANE

Wynik powtórzony w niezależnych badaniach, spójny w różnych grupach.



PRAWDOPODOBNE

Wsparte danymi, ale na małych próbach lub bez replikacji u dzieci autystycznych.



HIPOTEZA

Model teoretyczny lub pojedyncze doniesienia. Wymaga weryfikacji.

1 • Obciążenie językowe i trudność w rozumieniu



UDOKUMENTOWANE

Najlepiej potwierdzony mechanizm bezpośredni. Rydell i Mirenda ^[2] wykazali eksperymentalnie, że echolalia **rośnie** po wypowiedziach wysoko sterujących — poleceniach i pytaniach testujących — a **maleje** na rzecz mowy własnej dziecka po wypowiedziach nisko sterujących, czyli zwykłych komentarzach.

Innymi słowy: im większe obciążenie przetwarzaniem języka, tym więcej echa. Powtarzanie pojawia się tam, gdzie kończy się zasób potrzebny do samodzielnego złożenia zdania.

DLA PRAKTYKI: zamień „Jak się nazywa ten kolor?” na „O, niebieski klocek”. Zmniejszasz obciążenie i otwierasz miejsce na mowę własną.

2 • Echolalia pełni funkcje komunikacyjne



UDOKUMENTOWANE

Prizant i Duchan ^[1] wyodrębnili siedem funkcji echolalii natychmiastowej — m.in. podtrzymanie wymiany, potwierdzenie, prośbę, „ćwiczenie” zdania przed jego zrozumieniem i **samoregulację**. Trzy lata później opisano czternaście kategorii echolalii odroczonej ^[3].

Ustalenie powtórzono wielokrotnie — m.in. Cohn i wsp. ^[9] oraz Xie i wsp. ^[10], którzy analizowali echolalię jako pełnoprawne działanie językowe.

DLA PRAKTYKI: zanim zareagujesz, zadaj sobie pytanie „po co?”, a nie „jak to zatrzymać?”.

♦ JAK TO SPRAWDZONO

Badanie Rydell i Mirendy ^[2] jest przykładem projektu, który daje mocny wniosek przyczynowy. Tym samym dzieciom przedstawiano naprzemiennie dwa rodzaje wypowiedzi dorosłego — wysoko i nisko sterujące — a następnie liczono echa i wypowiedzi własne w każdym z warunków.

Ponieważ zmieniał się **wyłącznie sposób mówienia dorosłego**, a dziecko pozostawało to samo, różnicy w liczbie ech nie da się przypisać dziecku. To dlatego mechanizm 1 ma najwyższą ocenę, mimo że próba nie była duża.

▲ CZĘSTE NIEPOROZUMIENIE

„Wysoko sterujące” nie znaczy „surowe”. Ciepło zadane pytanie testujące („No powiedz mamie, co to jest?”) obciąża przetwarzanie dokładnie tak samo jak suche polecenie. Liczy się **struktura wypowiedzi**, nie ton głosu.

3 · Przetwarzanie całościowe języka

UDOKUMENTOWANE

Prizant [6] opisał, że część dzieci przyswaja język **całymi bryłami**: zapamiętuje i odtwarza gotowe fragmenty, zanim nauczy się rozbijać je na słowa i składać na nowo. Echolalia jest wtedy nie błędem, lecz **etapem** — surowcem, z którego dopiero powstanie mowa własna.

Samo zjawisko przetwarzania całościowego jest dobrze opisane w lingwistyce rozwojowej i w obserwacjach klinicznych. Ale tu potrzebne jest ważne rozróżnienie.

DLA PRAKTYKI: słuchaj, skąd pochodzi fraza. Źródło zwykle zdradza znaczenie, jakie dziecko jej nadało.

▲ ZJAWISKO TO NIE TO SAMO, CO PROTOKÓŁ TERAPEUTYCZNY

Popularny model **NLA** (Natural Language Acquisition, Blanc, 2012 [7]) z sześcioma etapami rozwoju bywa przedstawiany jako fakt naukowy. Krytyczna analiza Hutchins, Knox i Fletcher [8] wykazała, że **nie ma badań weryfikujących** ani samych etapów, ani skuteczności opartej na nich terapii.

Przetwarzanie całościowe jako zjawisko — tak. Sześć etapów jako udowodniona ścieżka rozwoju — nie. To rozróżnienie warto znać, zanim zainwestuje się w komercyjne szkolenie.

4 · Pamięć dosłowna i długotrwała

PRAWDOPODOBNE

Echolalia odroczone wymaga zapisania i odtworzenia długich fragmentów — całych scen z bajki, zdań usłyszanych tygodnie wcześniej, z zachowaną intonacją. Wskazuje to na relatywnie **zachowaną pamięć werbalną „słowo w słowo”** przy jednoczesnych trudnościach z przetwarzaniem znaczenia.

Echolalia natychmiastowa opiera się natomiast na pamięci krótkotrwałej i na materiale, który nie zdążył zostać zrozumiany [2][3][17].

DLA PRAKTYKI: ta sama mocna pamięć, która produkuje echo, jest zasobem — na niej opierają się skrypty i historyjki społeczne.

Dziecko, które powtarza całą scenę z bajki z zachowaną intonacją, nie ma problemu z pamięcią. Ma problem z rozbiciem tej sceny na części, którymi dałoby się rozporządzać.

SYNTEZA MECHANIZMU 3 I 4

♦ JAK WYGLĄDA „BRYŁA” JĘZYKA

Dziecko mówi „a-teraz-czas-na-śniadanie” jak jedno długie słowo, zawsze z tą samą melodią i zawsze w całości. Nie powie „czas na obiad” ani „teraz śniadanie”, bo fraza nie została jeszcze rozłożona na wymienne części.

Rozbijanie brył jest procesem stopniowym: najpierw pojawia się jeden wymienny element („czas na **obiad**”), potem kolejne. Właśnie dlatego pierwszym sygnałem postępu bywa nie zanik echa, lecz **drobna zmiana wewnątrz powtarzanej frazy**.

III

ROZDZIAŁ TRZECI

Co dzieje się w mózgu

Tu dowody pochodzą głównie z neurologii dorosłych. Są mocne — ale przeniesienie ich wprost na autyzm pozostaje ostrożną hipotezą, i tak je przedstawiamy.

● SZLAK POWTARZANIA ● HAMOWANIE IMITACJI ● REGULACJA NAPIĘCIA

Grzbietowy szlak powtarzania mowy

Powtarzanie i rozumienie to w mózgu dwie różne drogi. Pierwsza jest szybka i automatyczna, druga wolniejsza i łatwiejsza do przeciążenia.



RYC. 3 DROGA 1→2 DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD DROGI DO ZNACZENIA (3). GDY TA DRUGA JEST PRZECIĄŻONA, PIERWSZA ODPOWIADA SAMA.

5 • Powtarzanie to osobny obwód — może działać bez rozumienia



PRAWDOPODOBNE

Najmocniejszy dowód przychodzi z neurologii dorosłych. W **afazji transkorowej czuciowej** uszkodzenie odcina okolice odpowiedzialne za znaczenie, ale nienaruszony pozostaje grzbietowy szlak słuchowo-ruchowy. Efekt jest uderzający: pacjent **bezbłędnie powtarza** zdania, których nie rozumie. Pojawia się echolalia.

To dowodzi, że powtarzanie mowy jest odrębnym obwodem, zdolnym działać niezależnie od rozumienia.

OSTROŻNIE: to model wyjaśniający, nie dowód na uszkodzenie mózgu u dziecka autystycznego. Mechanizm ten sam — przyczyna inna.

+ DLACZEGO TO MA ZNACZENIE PRZY STOLE I W ŁAWCE

Jeśli droga powtarzania jest szybsza od drogi do znaczenia, to **echo pojawia się zanim dziecko zdąży zrozumieć zdanie**. Nie jest więc odmową ani ignorowaniem polecenia — jest tym, co zdążyło się wydarzyć pierwsze.

Praktyczny wniosek jest prosty i mierzalny: **daj drodze do znaczenia więcej czasu**. Pauza po zdaniu, krótsze polecenie, jedna informacja naraz. To nie jest ustępstwo — to wyrównanie szans między dwiema drogami.

♦ SKĄD WIADOMO, ŻE TO DWIE RÓŻNE DROGI

Z rozdzielenia obserwowanego u pacjentów neurologicznych: bywa zachowane powtarzanie przy zniesionym rozumieniu, ale zdarza się też odwrotnie — zachowane rozumienie przy niemożności powtórzenia. Gdyby to była jedna droga, taka podwójna dysocjacja nie byłaby możliwa.

6 · Osłabione hamowanie automatycznej imitacji

PRAWDOPODOBNE

Każdy mózg nieustannie i automatycznie „przymierza” to, co widzi i słyszy, do własnego aparatu ruchowego. Zwykle ta gotowość zostaje wyhamowana, zanim zamieni się w ruch albo dźwięk. **Echozjawiska** — echolalia i echopraksja — opisuje się jako **odhamowanie** tego naturalnego mechanizmu, powiązane z kontrolą czołową [19].

DLA PRAKTYKI: to dlatego echo nasila się przy zmęczeniu — hamowanie kosztuje zasoby, które właśnie się skończyły.

7 · Regulacja pobudzenia i napięcia

PRAWDOPODOBNE

Funkcja samoregulacyjna była w opisie echolalii od samego początku [1]. Znana, przewidywalna fraza działa jak kotwica: nie zmienia sytuacji, ale przywraca poczucie kontroli. Stąd powtarzalna obserwacja, że echolalia nasila się przy **przeciążeniu sensorycznym, zmianie rutyny i silnych emocjach** [9].

DLA PRAKTYKI: nagły wzrost echolalii to informacja o środowisku, nie o dziecku.

Na marginesie: modele neuroprzekąźnikowe

HIPOTEZA

W materiałach popularnych pojawiają się wyjaśnienia odwołujące się do funkcjonowania płatów czołowych i regulacji dopaminy [4]. Warto je znać, ale trzeba uczciwie powiedzieć: **brak badań rozstrzygających** u dzieci autystycznych. To kierunek poszukiwań, nie ustalenie.

♦ PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU III

Trzy mechanizmy z tego rozdziału łączy jedno: opisują **warunki**, w których echo się pojawia, a nie „defekt”, który je powoduje. Przeciążona droga do znaczenia, wyczerpane hamowanie, wysokie napięcie — każdy z tych stanów zdarza się także dorosłym, tyle że rzadziej i z mniejszym skutkiem.

Kiedy echolalia zwykle rośnie

Zestawienie sytuacji powtarzalnie opisywanych w literaturze [1][2][9] — z mechanizmem, który za nimi stoi.

SYTUACJA	MECHANIZM	CO POMAGA
Seria pytań i poleceń	1 · obciążenie	Przejdź na komentarze, jedna informacja naraz.
Hałas, tłum, ostre światło	7 · pobudzenie	Zmień miejsce, zanim zmienisz wymagania.
Zmiana planu dnia	7 · pobudzenie	Uprzedź, pokaż plan wizualnie, zostaw czas.
Koniec dnia, po lekcjach	6 · hamowanie	Obniż wymagania językowe — zasoby są wyczerpane.
Nowe, nieznane zadanie	1 · obciążenie	Rozłóż na kroki, dodaj wsparcie wizualne.
Silne emocje, także radość	7 · pobudzenie	Nie komentuj echa — poczekaj, aż napięcie opadnie.

Echolalia nie należy do autyzmu

Echo pojawia się w bardzo różnych stanach — i właśnie to jest najlepszym dowodem, że mamy do czynienia z działaniem pewnej sieci, a nie z objawem jednej diagnozy.

KIEDY WYSTĘPUJE	WIEK / KONTEKST	CZEGO TO DOWODZI
Rozwój typowy	ok. 8–30 mies.	Powtarzanie to normalny, powszechny sposób wchodzenia w mowę.
Afazja transkorowa czuciowa	po udarze	Sieć powtarzania działa nawet wtedy, gdy dostęp do znaczenia jest odcięty.
Ołepienie czołowo-skroniowe	dorosłość	Echo wraca, gdy słabnie czołowa kontrola hamująca.
Zespół Tourette’a	dzieciństwo / dorosłość	Echolalia jako złożony tik — odhamowanie automatycznej imitacji [19].
Katatonia	epizodycznie	Echo jako element zaburzeń napędu i inicjowania działania.
Inne stany rozwojowe	różny	M.in. zespół Landaua-Kleffnera, niepełnosprawność intelektualna, ślepotą wrodzona.

WNIOSEK DLA RODZICA I NAUCZYCIELA

Echolalia sama w sobie **nie jest** objawem diagnostycznym autyzmu i nie przesądza o niczym. Jest wyrazem działania sieci powtarzania mowy, która może ujawnić się z wielu powodów. Diagnozy nie stawia się na podstawie echa — i odwrotnie: obecność echolalii u dziecka bez diagnozy nie jest sama w sobie powodem do niepokoju przed trzecim rokiem życia.

♦ KIEDY JEDNAK WARTO SKONSULTOWAĆ

Gdy echolalia utrzymuje się jako **dominująca forma wypowiedzi po 3. roku życia**, gdy pojawia się nagle u dziecka, które wcześniej mówiło swobodnie, albo gdy towarzyszy jej regres innych umiejętności. To wskazania do konsultacji — nie do niepokoju.

♦ ECHO W ROZWOJU TYPOWYM – DLA PORÓWNANIA

Około pierwszego roku życia powtarzanie sylab i słów jest głównym narzędziem nauki mowy. Między 18. a 30. miesiącem dzieci neurotypowe powtarzają nadal, ale coraz częściej **przerabiają** usłyszaną frazę zamiast oddawać ją w całości. Po trzecim roku echo zwykle schodzi na margines.

Różnica u dzieci autystycznych nie polega więc na tym, że powtarzają, lecz na tym, **jak długo** powtarzanie pozostaje głównym narzędziem i jak duże bryły języka obejmuje.

Pół wieku badań

Kolejność ma tu znaczenie: widać, jak pytanie „jak to wygasić?” przesunęło się w stronę „po co dziecko powtarza?”.

1968

Pierwsza kontrolowana analiza

Fay i Butler badają odpowiedzi echowe metodą eksperymentalną ^[17].

1981

Przełom: echolalia ma funkcje

Prizant i Duchan opisują siedem funkcji echolalii natychmiastowej. Zmiana perspektywy, z której wyrasta cała późniejsza praktyka ^[1].

1983

Przetwarzanie całościowe — i korzyść z echa

Prizant opisuje gestaltowe przyswajanie języka ^[6]. W tym samym roku Charlop wykazuje, że echolalia **sprzyja** uczeniu się i generalizowaniu nazw ^[14].

1984

Czternaście kategorii echolalii odroczonej

Prizant i Rydell rozszerzają analizę funkcji na echa odroczone ^[3].

1987

Pierwsze ustrukturyzowane metody

McMorrow i wsp. opisują procedurę **cues–pause–point** ^[11].

1994

Dowód, że to my sterujemy ilością echa

Rydell i Mirenda: wypowiedzi wysoko sterujące zwiększają echolalię, komentarze — mowę własną ^[2].

2016

Pierwszy duży przegląd interwencji

Systematyczna ocena metod stosowanych wobec echolalii ^[16].

2022

Echolalia jako celowe działanie

Cohn i wsp. analizują echo z perspektywy osób autystycznych; głośność okazuje się sygnałem funkcji ^[9].

2024

Weryfikacja popularnego modelu

Hutchins i wsp. wykazują brak podstaw empirycznych dla etapów NLA ^[8].

2025

Dwoista natura echolalii

Analiza n=2555: echolalia bywa jednocześnie komunikacją i zachowaniem powtarzalnym — i to nie jest sprzeczność ^[5].

♦ CO SIĘ PRZEZ TE PIĘĆDZIESIĄT LAT ZMieniŁO

Punktem zwrotnym nie było żadne odkrycie biologiczne, tylko **zmiana jednostki opisu**: z formy echa na jego funkcję. Wszystko, co ma dziś najwyższą ocenę dowodową, pochodzi z badań, które pytały „po co”, a nie „jak często”.

▲ CO POZOSTAJE OTWARTE

Nie wiemy, dlaczego u jednych dzieci echolalia ustępuje mowie własnej, a u innych zostaje na stałe. Nie mamy też rozstrzygających badań porównujących skuteczność poszczególnych metod terapeutycznych ^{[15][16]}. To dwa najpoważniejsze braki w tej dziedzinie.

Czego nauka nie potwierdziła

Cztery zdania, które słyszy się najczęściej — i to, co na ich temat mówią badania.

MIT

„Echolalia to zły nawyk, który trzeba wygasić.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Odwrotnie. Charlop ^[14] wykazała, że echolalia **ułatwia** nabywanie i generalizowanie nazw. Wygaszanie echa usuwa narzędzie, którym dziecko właśnie się uczy.

MIT

„Echolalia oznacza, że dziecko nie rozumie i się nie komunikuje.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Dwadzieścia jeden opisanych funkcji ^{[1][3]} mówi coś przeciwnego. Echo bywa prośbą, zgodą, protestem, podtrzymaniem rozmowy albo sposobem na uspokojenie się.

MIT

„Sześć etapów NLA to udowodniona ścieżka rozwoju mowy.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Krytyczna analiza ^[8] nie znalazła badań weryfikujących ani etapów, ani skuteczności opartej na nich terapii. Przetwarzanie całościowe jest opisany zjawiskiem — konkretny protokół komercyjny to co innego.

MIT

„Jeśli echolalię ignorować, sama zniknie.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Brak dowodów. Przeglądy systematyczne ^{[15][16]} wskazują natomiast, że jakość badań nad wieloma popularnymi metodami jest niska — co jest argumentem za ostrożnością, a nie za bezczynnością.

▲ UCZCIWA KONKLUZJA

Nauka nie zna *jednej* przyczyny echolalii i prawdopodobnie nigdy nie znajdzie — bo echolalia nie jest chorobą, tylko zachowaniem o wielu funkcjach. Najlepiej potwierdzone jest natomiast to, co ma bezpośrednie przełożenie na praktykę: **echolalia komunikuje, a jej ilość zależy od tego, jak mówimy do dziecka.**

Cztery rzeczy, które z tego wynikają

Każdy z tych punktów opiera się na ustaleniu z poziomu „udokumentowane”. Nic tu nie jest domysłem.

Komentuj zamiast odpytywać

1

Mniej poleceń i pytań testujących, więcej opisu tego, co się właśnie dzieje. To jedyna zmienna po Twojej stronie, która ma potwierdzony wpływ na ilość echolalii.

RYDELL I MIRENDA, 1994

Pytaj „po co”, nie „jak to zatrzymać”

2

Zanim zareagujesz, ustal funkcję echa: prośba, potwierdzenie, podtrzymanie kontaktu czy samouspokojenie. Reakcja na funkcję działa — reakcja na formę nie.

PRIZANT I DUCHAN, 1981

Traktuj wzrost echolalii jako pomiar

3

Nagle nasilenie mówi o przeciążeniu, zmianie albo zmęczeniu. To informacja o sytuacji, nie o regresie dziecka.

COHN I WSP., 2022

Nie wygaszaj — przekierowuj

4

Echo jest materiałem do budowania mowy własnej. Skrypty, modelowanie i stopniowe wycofywanie podpowiedzi korzystają z tej samej pamięci, która produkuje echa.

CHARLOP, 1983 • KRANTZ I MCCLANNAHAN, 1993

Najskuteczniejsza zmiana w pracy z echolalią nie dotyczy dziecka. Dotyczy tego, jak mówi do niego dorosły.

WNIOSEK Z BADANIA RYDELL I MIRENDA, 1994

Pytania, które padają najczęściej

♦ MAM ODPOWIADAĆ NA ECHO, NAWET GDY NIE WIEM, O CO CHODZI?

Tak. Odpowiedz na najbardziej prawdopodobną intencję i obserwuj reakcję. Błędne odgadnięcie kosztuje mniej niż brak odpowiedzi — dziecko dostaje sygnał, że **powtarzanie coś zmienia**, a to podstawa całej dalszej komunikacji.

♦ CZY DA SIĘ DAĆ ZA DŁUGĄ PAUZĘ?

W praktyce błąd niemal zawsze idzie w drugą stronę. Dorośli przerywają ciszę znacznie szybciej, niż potrzebuje jej dziecko, u którego droga do znaczenia działa wolniej.

♦ CZY ECHOLALIA W KOŃCU ZNIKNIE?

U części dzieci maleje w miarę rozwoju mowy własnej, u części zostaje jako jeden ze sposobów mówienia — także w dorosłości. Realistyczny cel nie brzmi „zero echa”, tylko „**więcej sposobów na powiedzenie tego, co chcę**”.

Słowniczek pojęć

Terminy, które pojawiają się w tej broszurze i w dokumentacji terapeutycznej.

Echolalia natychmiastowa

Powtórzenie wypowiedzi w ciągu sekund od jej usłyszenia. Opiera się na pamięci krótkotrwałej.

Echolalia odroczone

Powtórzenie po godzinach, dniach lub miesiącach — często z zachowaną intonacją oryginału.

Echolalia interaktywna

Echo skierowane do rozmówcy, pełniące funkcję komunikacyjną. Zwykle głośniejsze.

Echolalia nieinteraktywna

Echo skierowane „do siebie”: samoregulacja, porządkowanie myśli, przetwarzanie sytuacji.

Przetwarzanie całościowe (gestalt)

Przyswajanie języka gotowymi „bryłami”, które dopiero później zostają rozłożone na elementy.

Echozjawiska

Wspólna nazwa dla echolalii (powtarzanie mowy) i echopraksji (powtarzanie ruchów).

Pęczek łukowaty

Wiązka włókien łącząca okolice słuchowe z ruchowymi mowy. Anatomiczna podstawa powtarzania.

Afazja transkorowa czuciowa

Zaburzenie, w którym powtarzanie jest zachowane, a rozumienie zaburzone. Klasyczne źródło echolalii u dorosłych.

Wypowiedź wysoko sterująca

Polecenie lub pytanie testujące, które wymusza określoną odpowiedź. Zwiększa ilość echolalii.

Wypowiedź nisko sterująca

Komentarz opisujący sytuację, nie wymagający odpowiedzi. Sprzyja mowie własnej dziecka.

Skrypt (script-fading)

Gotowa fraza wprowadzana celowo, a następnie stopniowo wycofywana, by dziecko przejęło inicjatywę.

Cues–pause–point

Procedura: wskazówka → pauza → wskazanie. Uczy zatrzymania się przed automatycznym powtórzeniem.

Bibliografia

Numeracja odpowiada odsyłaczom w tekście. Wszystkie pozycje pochodzą z recenzowanych czasopism naukowych lub przeglądów systematycznych.

- [1] Prizant, B.M., Duchan, J.F. (1981). The functions of immediate echolalia in autistic children. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 46(3), 241–249.
- [2] Rydell, P.J., Mirenda, P. (1994). Effects of high and low constraint utterances on the production of immediate and delayed echolalia in young children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 24(6), 719–735.
- [3] Prizant, B.M., Rydell, P.J. (1984). Analysis of functions of delayed echolalia in autistic children. *Journal of Speech and Hearing Research*, 27(2), 183–192.
- [4] Cleveland Clinic (2025). *Echolalia: What It Is, Causes, Types & Treatment*. Materiał informacyjny — cytowany jako źródło popularne, nie badanie.
- [5] McAllister, K. i wsp. (2025). Reports of echolalia — Simons Simplex Collection. *Autism Research*.
- [6] Prizant, B.M. (1983). Language acquisition and communicative behavior in autism: toward an understanding of the „whole” of it. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 48(3), 296–307.
- [7] Blanc, M. (2012). *Natural Language Acquisition on the Autism Spectrum*. Communication Development Center.
- [8] Hutchins, T.L., Knox, S.E., Fletcher, E.C. (2024). Natural language acquisition and gestalt language processing: a critical analysis. *Autism & Developmental Language Impairments*, 9.
- [9] Cohn, E.G., McVilly, K.R., Harrison, M.J., Stiegler, L.N. (2022). Repeating purposefully: empowering educators with functional communication models of echolalia. *Autism & Developmental Language Impairments*, 7.
- [10] Xie, F., Pascual, E., Oakley, T. (2023). Functional echolalia in autism speech. *Frontiers in Psychology*, 14.
- [11] McMorro, M.J., Foxx, R.M., Faw, G.D., Bittle, R.G. (1987). Cues-pause-point language training. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 20, 11–22.
- [12] Ganz, J.B., Kaylor, M., Bourgeois, B., Hadden, K. (2008). The impact of social scripts and visual cues on verbal communication. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*.
- [13] Krantz, P.J., McClannahan, L.E. (1993). Teaching children with autism to initiate to peers: script-fading. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 26(1), 121–132.
- [14] Charlop, M.H. (1983). The effects of echolalia on acquisition and generalization of receptive labeling. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 16(1), 111–126.
- [15] Blackburn, C. i wsp. (2023). A systematic review of interventions for echolalia in autistic children. *International Journal of Language & Communication Disorders*.
- [16] Neely, L. i wsp. (2016). Treatment of echolalia in individuals with ASD: a systematic review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*.
- [17] Fay, W.H., Butler, B.V. (1968). Echoic responses in autistic and comparable mentally retarded children. *Journal of Speech and Hearing Research*.
- [18] Vicker, B. (1999). *Functional categories of delayed echolalia*. Indiana Resource Center for Autism.
- [19] Ganos, C., Ogrzal, T., Schnitzler, A., Münchau, A. (2012). The pathophysiology of echopraxia/echolalia: relevance to Gilles de la Tourette syndrome. *Movement Disorders*, 27(10), 1222–1229.

NOTA O CYTOWANIU

Pozycja [4] jest materiałem informacyjnym instytucji medycznej, nie badaniem naukowym — cytujemy ją wyłącznie jako przykład tego, jak hipotezy neuroprzebiegowe funkcjonują w obiegu popularnym. Pozycja [7] to publikacja komercyjna; jej ocenę empiryczną zawiera pozycja [8].

Szybka ściągawka

Jedna strona, którą warto mieć w klasie, w gabinecie albo na lodówce.

Rób to

- Komentuj, co widzisz, zamiast odpytywać.
- Zostaw pauzę — dłuższą, niż wydaje się potrzebna.
- Odpowiadaj na **funkcję** echa, nie na jego formę.
- Modeluj gotową frazę zamiast żądać powtórzenia.
- Szukaj źródła powtarzanej frazy — tam jest znaczenie.

Unikaj tego

- „Nie powtarzaj”, „Powiedz normalnie”.
- Serii pytań testujących pod rząd.
- Wygaszania echa bez zrozumienia jego funkcji.
- Przerwywania w połowie powtarzanej frazy.
- Traktowania wzrostu echolalii jako regresu.

Gdy echolalia nagle rośnie

- Sprawdź hałas, światło, tłum, zapach.
- Sprawdź, co się zmieniło w planie dnia.
- Sprawdź, czy zadanie nie jest za trudne.
- Sprawdź porę dnia i poziom zmęczenia.
- Zmniejsz wymagania językowe, nie podnoś ich.

Zapamiętaj

- Echolalia to **komunikacja**, nie zakłócenie.
- To etap drogi do mowy własnej, nie ślepy zaulek.
- Głośniejsze echo częściej znaczy: „mówię do ciebie”.
- Ilość echa zależy od tego, jak mówi dorosły.
- Echolalia nie jest wyłączna dla autyzmu.

Trzy zamiany do wypróbowania jutro

SYTUACJA	ZAMIAST	SPRÓBUJ
Chcesz, żeby dziecko o coś poprosiło	„Powiedz: chcę sok.”	„Sok. Chcę sok.” — modelujesz frazę, nie żądasz jej powtórzenia.
Chcesz nazwać przedmiot	„Co to jest? No co to jest?”	„O, duży czerwony samochód.” — komentarz zamiast pytania testującego.
Dziecko powtarza w kółko jedną frazę	„Nie powtarzaj.”	Ustal, skąd fraza pochodzi, i odpowiedz na to, czego dotyczy.

Zanim zapytasz, jak zatrzymać powtarzanie — zapytaj, po co ono jest.

To pytanie zmieniło całą dziedzinę w 1981 roku. W codziennej pracy z dzieckiem zmienia zwykle znacznie więcej niż jakakolwiek technika.



7 mechanizmów z oceną siły dowodów

4 zweryfikowane mity

19 pozycji z recenzowanych czasopism

1 ściągawka do powieszenia w klasie

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej

Poradniki edukacyjno-terapeutyczne

Materiał do bezpłatnej dystrybucji w placówkach oświatowych